Anest®
Clínica de Anestesiologia Chapecó

Relatório de Segurança do Paciente
Macroárea: Cultura de Segurança

Alinhamento às ROPS – Ciclo 2025

3º Trimestre de 2025

ROP 1: Responsabilização pela Qualidade

Diretriz: A alta administração demonstra responsabilização pela qualidade do atendimento fornecido pela organização.

Pontos-chave

- ✓ A qualidade é um item permanente na pauta de todas as reuniões regulares da alta administração..
- ✓ São definidos os principais indicadores sistêmicos que serão usados para monitorar o desempenho em qualidade da organização.
- ✓ Reuniões trimestralmente, o desempenho em qualidade da organização é monitorado e avaliado quanto às metas e objetivos acordados.
- ✓ O resulta de desempenho em qualidade é usado para definir a pauta, e como insumo no planejamento estratégico para um plano integrado de melhoria da qualidade.
- ✓ Indicadores de desempenho em qualidade estão diretamente ligados às metas e objetivos estratégicos, distribuídos entre áreas prioritárias e alinhados à missão institucional.

Os indicadores clínico-assistenciais, influenciam resultados financeiros e reputacionais, sustentando os pilares estratégicos:

Eficiência Financeira e Operacional

- Controle de custos fixos e margens.
- Monitoramento de produtividade anestésica e utilização de salas.

Segurança do Paciente e Qualidade Assistencial

- Fortalecer protocolos de prevenção (infecção, glicemia, hipotermia).
- Garantir alta sem eventos anestésicos.

Sustentabilidade e Crescimento

- Ampliação de consultas pré-anestésicas.
- Desenvolvimento de novos serviços ambulatoriais.

Governança Clínico-Financeiro

- Auditoria contínua de resultados e conformidades.
- Capacitação das equipes em indicadores de qualidade e custo..

ROP 2: Gestão de Incidentes de Segurança do Paciente

Diretriz: Implantação de sistema estruturado para gerenciamento de incidentes, com foco em notificação, aprendizado e prevenção.

Pontos-chave

- ✓ Sistema informatizado de notificação ativa de incidentes anestésicos.
- ✓ Classificação de incidentes por tipo e gravidade, conforme critérios padronizados.
- ✓ Reuniões mensais de análise de causa e retroalimentação dos aprendizados.
- ✓ Adoção de protocolos de resposta rápida para incidentes críticos.

Resultados

+27%

Aumento nas notificações voluntárias (indicativo de cultura madura).

100%

Dos incidentes graves analisados pelo Comitê de qualidade e documentados.

Implementado

Plano de ação corretiva com prazos e responsáveis definidos.

ROP 3: Divulgação de Incidentes (Disclosure)

Diretriz

Aplicação da Política PLI.ANES.0007-00, que define o processo de comunicação ética, transparente e empática dos incidentes.

Princípios Operacionais

- ✓ Comunicação clara e sem atribuição de culpa.
- ✓ Realização em até 24h após constatação do incidente, salvo contraindicação clínica.
- ✓ Conduzida pelo Responsável Técnico, com participação do hospital parceiro.
- ✓ Apoio emocional garantido a pacientes, familiares e equipe envolvida.

Fluxo Resumido

1. Identificação e notificação.
1. Avaliação técnica e definição de disclosure.
1. Planejamento conjunto com hospital parceiro.
1. Comunicação ao paciente/família.
1. Registro e análise de aprendizados.

Ética e Compliance

A política segue as diretrizes da LGPD, Código de Ética Médica, RDC 36/2013, ANS e Qmentum, promovendo governança e humanização no processo.

ROP 4: Relatórios Trimestrais de Segurança do Paciente

> *A alta administração deve receber relatórios trimestrais consolidados, com indicadores, análises e planos de melhoria.*

Conteúdo do Relatório

Resultados dos indicadores de segurança.

Incidentes e lições aprendidas.

Ações corretivas e preventivas implementadas.

Desempenho frente às metas estratégicas.

Estrutura do Relatório	Periodicidade
Indicadores de Processos	Mensal/Trimestral
Indicadores de Resultado	Trimestral
Análise de Tendências	Trimestral
Planos de Ação	Conforme necessidade

Aplicação para Decisões Estratégicas

Os relatórios trimestrais subsidiam decisões táticas e estratégicas, fomentando:

Alocação de recursos

Direcionamento para áreas críticas identificadas nos relatórios, com priorização baseada em risco-benefício.

Treinamentos e capacitações

Reforço de competências técnicas específicas conforme lacunas identificadas nas análises de incidentes.

Revisão de processos

Atualização de fluxos assistenciais com foco em segurança, qualidade e eficiência operacional.

Suporte as metodoligas

Suporte institucional às recomendações técnicas do Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente.

Relatório de Segurança do Paciente

Notificação de Incidentes

3º Trimestre de 2025

Período de referência: julho a setembro de 2025

Contextualização Geral

Indicadores Principais

Indicador	Valor
Total de incidentes	70
Eventos anestésico-cirúrgicos	27 (38%)
Respiratórios/via aérea	17 (24%)
Falhas de processo	9 (13%)
Medicamentos	8 (11%)
Outros eventos	9 (13%)

Período: julho a setembro de 2025 | Fonte: Notificações Axreg e Relatórios Unimed

Resumo do trimestre

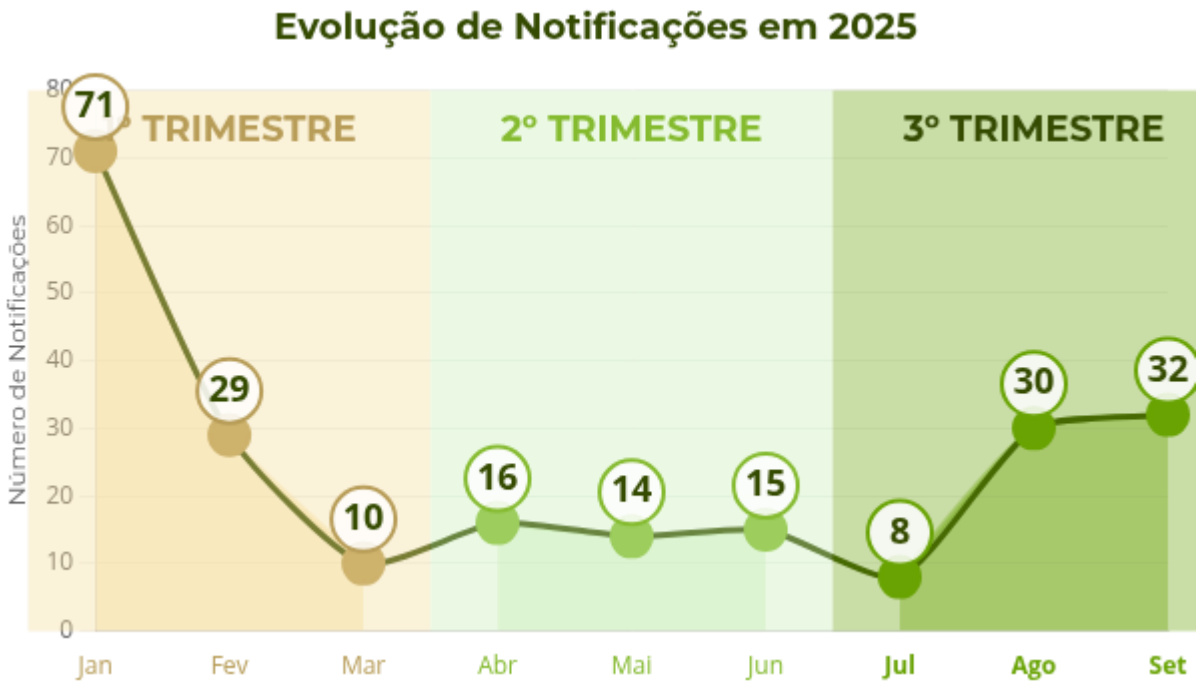
Fortalecimento da cultura institucional de notificação e amadurecimento do uso do sistema Axreg como canal oficial de registro.

Prevalência de ocorrências anestésico-cirúrgicas (38%), seguidas por incidentes respiratórios e de via aérea (24%).

Maioria dos eventos com dano leve ou ausência de dano (60%), porém 15 casos com desfechos moderados a graves demandam análise aprofundada.

Dados indicam maturidade crescente da cultura de segurança, com redução de subnotificação e adesão progressiva aos registros digitais.

Tendências e Distribuição Temporal



Análise: *O 3º trimestre mostra recuperação expressiva nas notificações (Julho: 8 → Setembro: 32), indicando maior maturidade da cultura de segurança. O padrão anual mostra pico inicial (1T com 110 eventos), queda e estabilização (2T com 45 eventos) e retomada consistente no trimestre atual (70 eventos).*

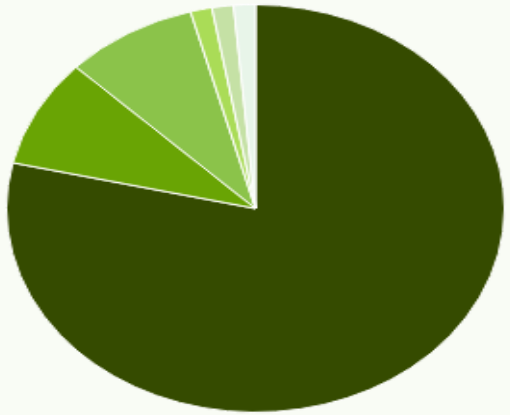
Notificações por mês (2025)

Mês	Qtd	Vis.
1º Trimestre		
Janeiro	71	
Fevereiro	29	
Março	10	
2º Trimestre		
Abril	16	
Maio	14	
Junho	15	
3º Trimestre (Atual)		
Julho	8	
Agosto	30	
Setembro	32	
Total Anual	**225**	

70	+275%	31%
3º Trimestre	Jul → Set	Do total anual

Distribuição por Local e Canal de Registro

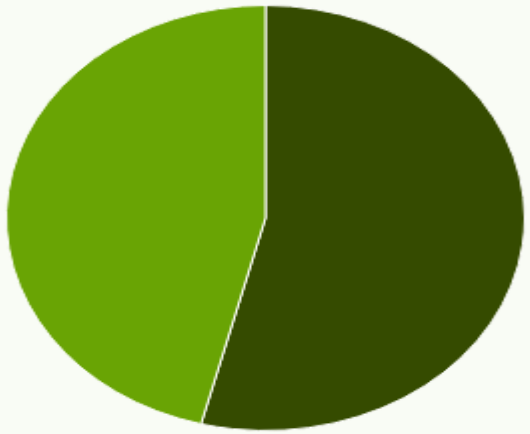
Local de Ocorrência



70 incidentes | Centro Cirúrgico: 78,6%

- Centro Cirúrgico: 78.6%
- Centro Obstétrico: 8.6%
- SRPA: 8.6%
- Hemodinâmica: 1.4%
- Hospital Dia: 1.4%
- Tomografia: 1.4%

Canal de Registro

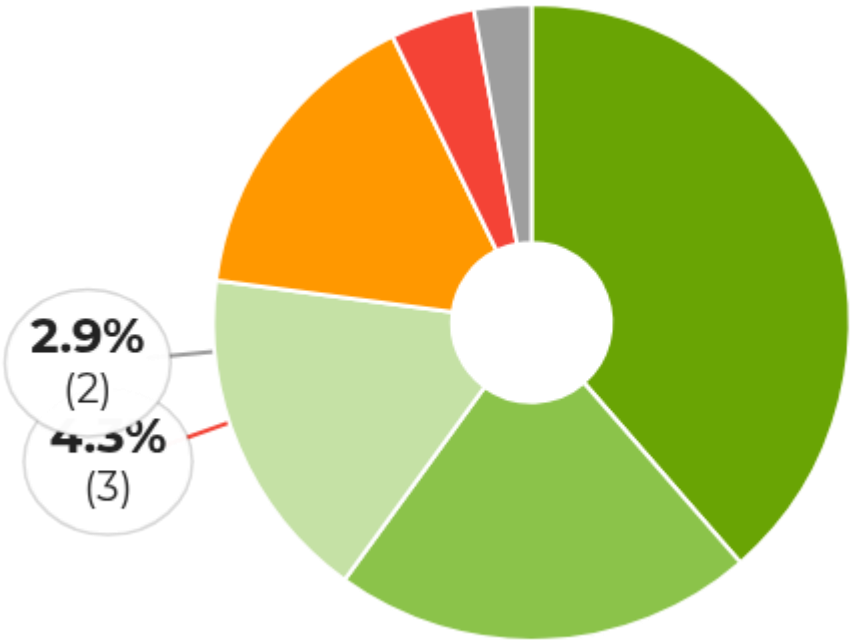


Axreg: 38 registros | Relatórios Unimed: 32 registros

- Axreg: 54%
- Relatório Hospital Unimed: 46%

A alta concentração no Centro Cirúrgico (78,6%) reflete a complexidade técnica, rotatividade e risco anestésico-cirúrgico inerente ao setor. Os canais de registro demonstram boa distribuição entre Axreg (54%) e Relatório Hospital Unimed (46%), evidenciando redução de subnotificação e adesão progressiva aos registros digitais.

Classificação por Gravidade e Dano - 3º Trimestre



⚠ Distribuição dos 70 incidentes por gravidade

Classificação	Qtd	%
Dano leve	27	38,6%
Sem dano	15	21,4%
Não conformidade	12	17,1%
Dano moderado	11	15,7%
Dano grave	3	4,3%
Sem dados suficientes	2	2,9%
Total Geral	**70**	**100%**

Leitura: A maioria dos eventos apresentou baixo dano (60% leves ou sem dano); porém 15 casos moderados/graves (20%) exigem abordagem sistêmica e análise aprofundada para implementação de medidas corretivas estruturantes.

Eventos com Dano Grave

(3 casos – 4,3%)

Classificação dos eventos graves

Tipo	Qtd
Complicação relacionada ao procedimento cirúrgico	1
PCR durante indução anestésica	1
Sangramento anormal relacionado ao procedimento	1

Fatores contribuintes e impacto:

Eventos-sentinela: requerem análise de causa raiz formal e plano de ação imediato com monitoramento pela alta gestão.

Fatores comuns: pacientes de alto risco clínico, protocolos ativados tardiamente e comunicação interprofissional limitada.

Respostas institucionais: equipes demonstraram boa capacidade técnica reativa, mas evidenciaram fragilidade nas barreiras preventivas e preditivas.

Eventos com Dano Leve

(27 casos -21,4%)

Tipo	QTD
Bradicardia	7
Laringoespasmo	3
Hipotensão intraoperatória associada ao posicionamento cirúrgico	2
Via aérea difícil (VAD) não prevista na avaliação pré-anestésica	2
Broncospasmo	1
Complicação relacionada ao procedimento cirúrgico	1
Conexões inadequadas entre dispositivos ventilatório	1
Dor não controlada no pós-operatório imediato	1
Falha de raquianestesia (ineficácia do bloqueio após punção)	1
Falha técnica na fixação/posicionamento de dispositivo de via aérea,	1
Lesão de pele relacionada a dispositivo médico	1
Material incompleto para IOT (intubação orotraqueal)	1
Obstrução parcial de vias aéreas (estridor laríngeo)	1
Queda com danos leves	1
Reação adversa medicamentosa	1
Reação neurológica transitória possivelmente associada à absorção sistêmica de anestésico local.	1
Retirada acidental do cateter peridural	1

Análise crítica

A frequência elevada de incidentes leves sugere maturidade crescente na identificação e registro de eventos, porém evidencia fragilidades preventivas. A análise indica necessidade de padronização das etapas críticas do ato anestésico-cirúrgico, especialmente em aspectos técnicos e de preparo anestésico.

Eventos com Dano Moderado

(11 casos – 15,7%)

Classificação por subtipo

Tipo	Qtd
Encaminhamento não programado para UTI	3
Sangramento anormal relacionado ao procedimento	3
Hipóxia ou hipoxemia no pós-operatório	2
Reação adversa medicamentosa	1
Complicação relacionada ao procedimento cirúrgico	1
Prescrição/administração inadequada de antibiótico profilático	1

Achados e recomendações

Deficiências de planejamento perioperatório: falhas principalmente em pacientes ASA III e IV, com ausência de monitoramento de risco adequado.

Causas sistêmicas: ausência de reserva prévia de leito crítico, falha na validação do destino pós-anestésico e inconsistência na aplicação de protocolos tempo-dependentes.

Deterioração clínica previsível: eventos que resultaram em necessidade de intervenção adicional e prolongamento do cuidado além do planejado inicialmente.

Eventos Sem Dano

(15 casos – 21,4%)

Incidentes interceptados antes de atingir o paciente

Tipo	Qtd
Via aérea difícil (VAD) não prevista	4
Falha de equipamento/material	2
Prescrição/administração inadequada de antibiótico profilático	2
Ausência de avaliação pré-anestésica	1
Bradicardia	1
Laringoespasmo	1
Dificuldade de IOT	1
Falha no protocolo de abreviação do jejum	1
Não conformidade no fluxo de materiais estéreis	1
Náusea/vômito intraoperatório	1

Leitura e Recomendações

Near miss: Eventos sem dano demonstram eficácia das defesas de contenção — situações em que a falha foi detectada antes de atingir o paciente.

Vigilância ativa: Esses registros são indicadores positivos de vigilância, porém reforçam a necessidade de sistemas eletrônicos de alerta.

Oportunidade de melhoria: Reduzir dependência exclusiva da percepção humana para interceptar falhas, implementando bloqueios automáticos nos sistemas.

Esses dados devem alimentar relatórios de quase falhas (near miss), fundamentais para a prevenção de eventos graves futuros.

Não Conformidades

(12 casos – 17,1%)

Tipos de não conformidades identificadas

Tipo	Qtd
Falha de segurança/rastreabilidade de psicotrópicos	7
Não conformidade no fluxo de materiais estéreis	1
Comportamento não colaborativo do anestesista	1
Falha de processo/comunicação interprofissional	1
Falha no consentimento informado	1
Ausência de avaliação pré-anestésica	1

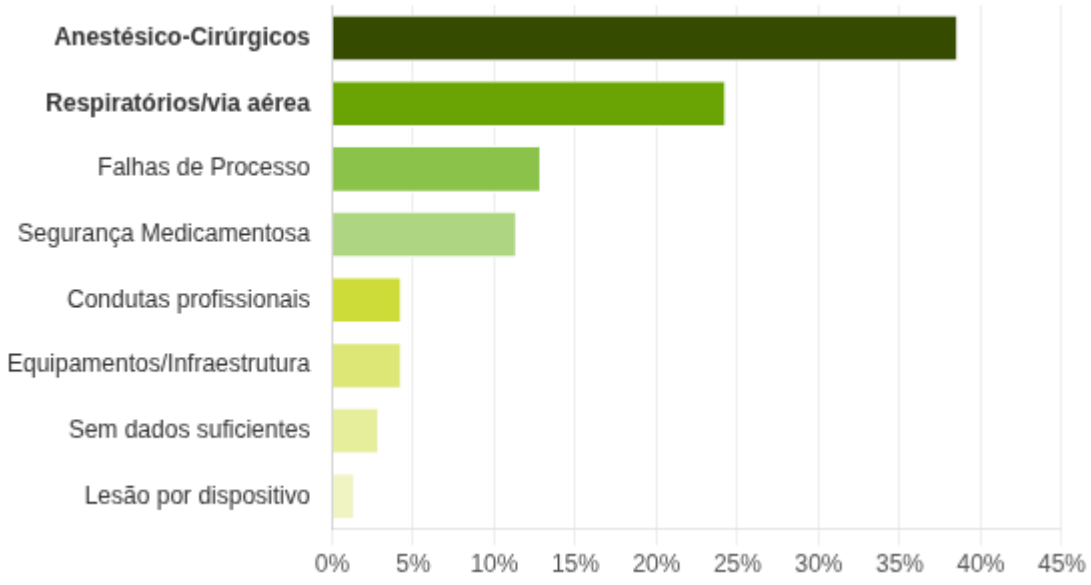
Risco institucional

Impacto regulatório: falhas na rastreabilidade de psicotrópicos (58% dos casos) representam risco institucional significativo perante órgãos reguladores.

Vulnerabilidade legal: ausência de documentação crítica (avaliação pré-anestésica, consentimento informado) compromete segurança jurídica institucional.

Padrões Assistenciais Identificados

Distribuição por Categoria (%)



Categoria	Qtd	%
Eventos Adversos Anestésico-Cirúrgicos	**24**	**38,6%**
Incidentes relacionados ao sistema respiratório	**17**	**24,3%**
Falhas de Processo/Fluxo Assistencial	9	12,9%
Medicamentos/Segurança Medicamentosa	8	11,4%
Condutas profissionais	3	4,3%
Equipamentos/Infraestrutura	3	4,3%
Sem dados suficientes	2	2,9%
Lesão de pele por dispositivo	1	1,4%

Análise: A predominância de eventos anestésico-cirúrgicos (38,6%) e complicações respiratórias (24,3%) corresponde ao perfil perioperatório da instituição e confirma áreas prioritárias para protocolos de segurança. Os eventos relacionados a falhas de processo (12,9%) e medicamentos (11,4%) aparecem como terceiro e quarto grupos mais frequentes, sugerindo oportunidades de melhoria em fluxos assistenciais e revisão farmacêutica.

Eventos Anestésico-Cirúrgicos (38%)

Eventos Adversos Anestésico-Cirúrgicos 38%

Subtipo	Qtd
Bradicardia	8
Sangramento anormal relacionado ao procedimento cirúrgico	4
Complicação relacionada ao procedimento cirúrgico	3
Hipotensão intraoperatória associada ao posicionamento	2
Dor não controlada no pós-operatório imediato	1
Falha de raquianestesia (ineficácia do bloqueio após punção)	1
Instabilidade hemodinâmica no pós-operatório imediato	1
Náusea/vômito intraoperatório relacionado à anestesia	1
PCR durante indução anestésica	1
Queda com danos leves	1
Retirada acidental do cateter peridural	1

A maioria dos eventos foi identificada precocemente e revertida sem dano permanente, evidenciando boa capacidade técnica e resposta reativa das equipes assistenciais, embora demonstre necessidade de fortalecimento de barreiras preventivas.

Incidentes relacionados ao sistema respiratório (24%)

Distribuição por subtipo

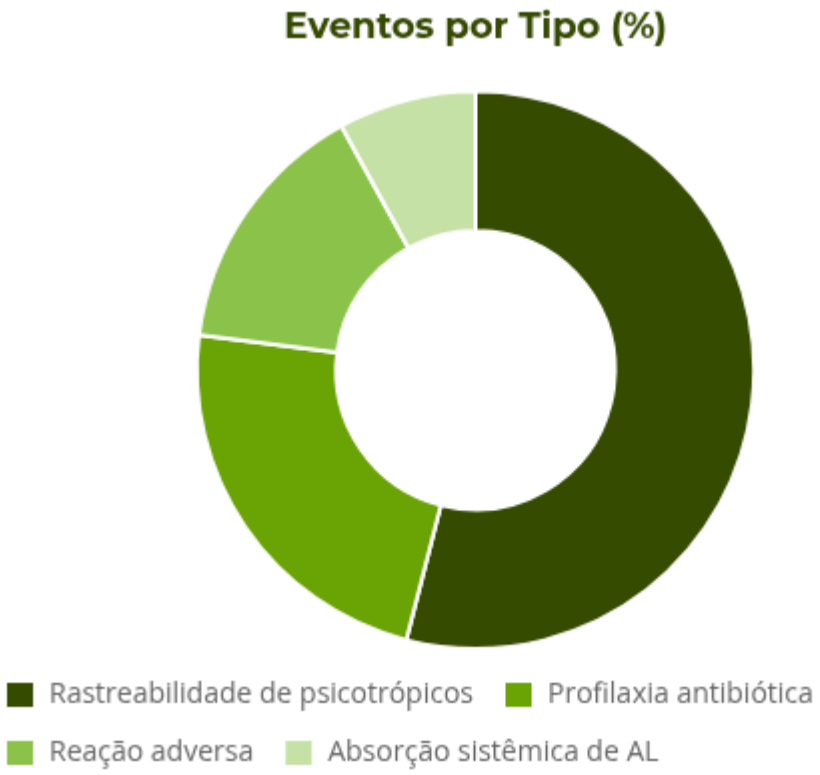
Subtipo	Qtd
VAD não prevista na avaliação pré-anestésica	6
Laringoespasmo	4
Hipóxia ou hipoxemia no pós-operatório	2
Broncospasmo	1
Falha técnica na fixação/posicionamento de dispositivo de via aérea	1
Material incompleto para IOT	1
Dificuldade de IOT	1
Obstrução parcial de vias aéreas (estridor laríngeo)	1

Fragilidades identificadas

Fragilidade na avaliação pré-anestésica: ausência de identificação de preditores de via aérea difícil em pacientes ASA III/IV.

Impacto clínico: 70% dos eventos resultaram em instabilidade respiratória com necessidade de intervenção não programada.

Eventos Relacionados a Medicamentos (13 casos – 18%)



Distribuição por subtipo

Subtipo	Qtd	%
Falhas de rastreabilidade de psicotrópicos	7	54%
Profilaxia antibiótica inadequada	3	23%
Reação adversa medicamentosa	2	15%
Reação neurológica (absorção sistêmica de AL)	1	8%
Total	**13**	**100%**

Falhas de Processo e Comunicação (7 casos)

Tipos de Falhas Identificadas

Falha	Qtd
Ausência de avaliação pré-anestésica	2
Encaminhamento não programado para UTI	2
Falha de processo/comunicação interprofissional	1
Falha no protocolo de abreviação do jejum	1
Falha no consentimento informado	1
Total	**7**

Risco Lacunas persistentes no uso do checklist "Time Out" e na conferência do destino pós-operatório, impactando diretamente o fluxo de pacientes críticos e a previsibilidade de leitos. Comunicação interprofissional entre anestesia, cirurgia e enfermagem apresenta falhas recorrentes — especialmente nos repasses transoperatórios e pós-anestésicos.

Consequências dos Incidentes

Distribuição de Consequências

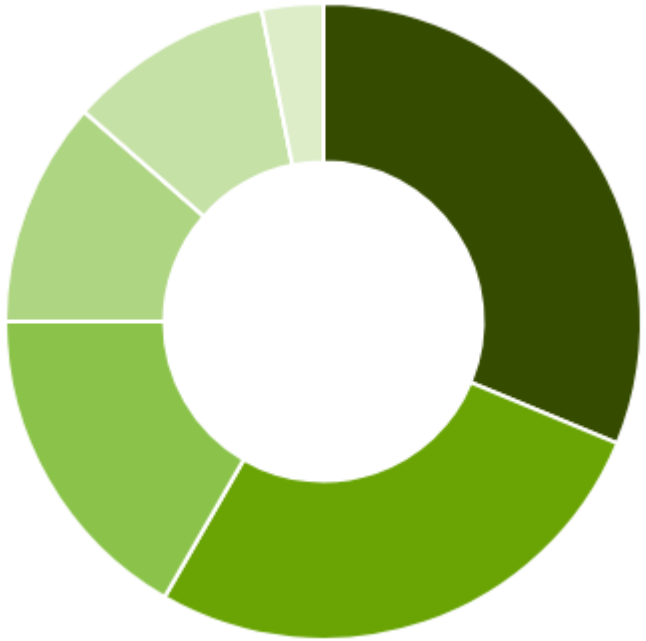
O perfil das consequências evidencia capacidade de contenção de eventos (74,3% com dano leve ou sem dano), mas ainda dependente da ação humana e da expertise das equipes. Necessário evoluir para controles preventivos automatizados.

Detalhamento por Consequência

Consequência	Qtd	%
Alterações clínicas leves/riscos tratados	38	**54,3%**
Falha detectada sem dano (near miss)	14	**20,0%**
Falha de documentação	8	**11,4%**
Risco iminente/UTI/Suporte avançado	3	**4,3%**
Sem dados suficientes	2	**2,9%**
Quebra de biossegurança	2	**2,9%**
Ruptura da continuidade do cuidado	2	**2,9%**
Vulnerabilidade legal/administrativa	1	**1,4%**
Total Geral	**70**	**100%**

Causas Raiz dos Incidentes

Categoria



- Fatores Inerentes: 30%
- Fatores de Sistema: 26%
- Fatores Clínicos: 16%
- Processo/Comunicação: 11%
- Fatores Humanos: 10%
- Equipamentos: 3%

Detalhamento por Categoria

Categoria	Qtd	%
Fatores inerentes ao procedimento	21	**30%**
Sistema/Organizacionais	18	**26%**
Clínicos do paciente	11	**16%**
Processo/Comunicação interprofissional	8	**11%**
Fatores humanos	7	**10%**
Equipamentos/Dispositivos	2	**3%**
Total	**67**	**100%**

Modelo: Distribuição compatível com o modelo de causalidade de James Reason (queijo suíço) e Protocolo de Londres. A maioria das falhas não decorre de erro individual, mas de lacunas estruturais e processuais que se alinham, permitindo eventos adversos. O padrão 30-26-16% reflete maturidade do sistema de identificação de causas.

Anest® Clínica de Anestesiologia Chapecó

Fatores Inerentes ao Procedimento (30%)

Complicações inerentes ao ato anestésico-cirúrgico

CAUSA RAÍZ	Qtd
Resposta vagal durante procedimento anestésico	8
Reatividade laríngea em pediatria	3
Reflexo laríngeo na extubação	2
Alteração hemodinâmica por posicionamento	1
Evento relacionado ao procedimento cirúrgico	1
Falha funcional do bloqueio raquidiano	1
Falha na avaliação pré-anestésica (VAD)	1
Verificação prévia de materiais de via aérea	1
Fisiopatologia multifatorial	1
Perfuração colateral em angioplastia retrógrada	1
Hipersensibilidade cutânea leve	1

Estas complicações são previsíveis no contexto perioperatório e ocorrem mesmo com assistência tecnicamente adequada. Destacam a importância da previsão de riscos específicos e da prontidão da equipe para sua detecção e manejo precoce.

Fatores de Sistema/Organizacionais (26%)

Exemplos de fatores organizacionais identificados

CAUSA RAÍZ	Qtd
VAD não prevista na avaliação pré-anestésica.	6
Falha no protocolo do psicobox	4
Quebra de biossegurança	2
Ausência de planejamento prévio	1
Ausência de profilaxia antiemética	1
Sem rechecagem sistemática da posição do tubo	1
Falha no protocolo de jejum abreviado	1
Avaliação de risco de queda (falha de aplicação)	1
Planejamento perioperatório insuficiente	1

Os achados revelam fragilidade operacional com protocolos instituídos. A reincidência de falhas relacionadas ao PSICOBOX e protocolos críticos demonstra elevada dependência do comportamento individual na adesão aos controles sistêmicos. Necessária revisão da automação de alertas e barreiras eletrônicas que reduzam essa dependência.

Fatores Clínicos do Paciente (16%)

Condições clínicas que influenciaram desfechos

CAUSA RAÍZ	Qtd
Instabilidade hemodinâmica (anestesia/procedimento)	2
Atonia uterina refratária	1
Hemostasia cirúrgica insuficiente em área difícil	1
Choque séptico + disfunção miocárdica séptica	1
Desconhecimento de alergias	1
Estenose traqueal leve (anatômico)	1
Fragilidade tegumentar (idoso)	1
Inadequação técnica de máscara laríngea	1
Toxicidade leve por anestésico local	1
Alteração hemodinâmica por posicionamento	1

Ação Recomendada:

Implementação de estratificação de risco clínico mais rigorosa e planejamento anestésico individualizado. O sistema atual demonstra lacuna no cruzamento de informações clínicas e histórico anestésico prévio, o que dificulta a antecipação de riscos, especialmente em pacientes ASA III/IV.

SEÇÃO II

ANÁLISE APROFUNDADA

Eventos Adversos Moderados e Graves

Eventos Analisados

15

Casos com dano moderado

Fontes de Detecção

3

Metodologia

100%

Análise conforme

Classificação dos Eventos Adversos (n=15)

⚠ Distribuição por categoria e gravidade

Categoria do evento	Casos	Gravidade
Encaminhamento não programado para UTI	6	Moderada
Complicação anestésica grave (PCR)	2	Grave
Hemorragia intra/pós-operatória	2	Grave
Infecção relacionada à assistência (IRAS)	1	Grave
Óbito intraoperatório	1	Óbito
Complicação cardiovascular/hemodinâmica	1	Grave
Complicação respiratória (laríngea)	1	Moderada
Outros eventos clínicos significativos	1	Moderada

Foco: Hemorragia, instabilidade hemodinâmica e comprometimento de via aérea concentraram os eventos de maior gravidade. A presença de óbito reforça a necessidade de abordagem sistêmica preventiva.

Fatores Contribuintes e Barreiras

Fatores do Paciente

Fatores	Valor
Comorbidades presentes	53%
Idosos (>70 anos)	30%
Estados clínicos críticos prévios	PCR, choque, acidose
ASA III/IV sem planejamento	36% dos casos

Dados extraídos da análise de causa raiz dos 15 eventos adversos com danos moderados a graves.

Barreiras

Funcionaram adequadamente:

Monitorização multiparamétrica contínua, garantindo detecção precoce.

Resposta anestésica e de enfermagem rápida e coordenada durante eventos críticos.

Protocolos críticos (sepse, atonia uterina, hemorragia) disponíveis e aplicados.

Insuficientes ou falharam:

Campos obrigatórios e alertas eletrônicos ausentes nos prontuários anestésicos.

Validação formal do destino pós-anestésico em ASA III/IV inexistente.

Ativação tardia de protocolos em 3 casos com desfecho grave.

Documentação inadequada de volume infundido e perda sanguinea real.

Cultura e Contexto Organizacional

Maturidade da Cultura de Segurança

Dimensão	Achado
Resposta a crises	Capacidade reativa e coordenação
Aderência a protocolos	Boa durante o evento; prevenção sistêmica frágil
Comunicação	Eficiente porém dependente de iniciativa individual
Automação	Alertas/bloqueios eletrônicos pouco integrados

A instituição demonstra cultura de segurança em evolução. O desafio está em evoluir de um sistema reativo para um modelo preventivo, com automação de barreiras e controles sistêmicos.

Recomendações – Curto Prazo (0–60 dias)

Ações prioritárias para implementação imediata, com foco em controles críticos e protocolos de segurança:

Ação	Indicador
Implementar alertas obrigatórios no prontuário anestésico para antibióticos em alérgicos e campos.	% de prontuários com campos completos
Revisar checklist de destino pós-operatório	% ASA III/IV com destino validado
Implementar dupla checagem dos MAV administrados pelo anestesista na SRPA.	% de medicações com registro de dupla checagem
Intensificar identificação de preditores de via aérea difícil na avaliação pré-anestésica	% de VADs não previstas vs. total VADs

● Alta prioridade ● Prioridade intermediária

Recomendações – Médio Prazo (60–120 dias)

Ações estruturantes para consolidação de processos e capacitação das equipes no horizonte de 2 a 4 meses:

Ação	Métrica de sucesso
Atualizar formulário de avaliação pré-anestésica com campo obrigatório de "planejamento de recuperação" para todos os pacientes ASA III/IV	Adesão ao preenchimento do campo (%)
Realizar treinamento multiprofissional sobre planejamento perioperatório seguro, protocolos de hemorragia e sepse	Taxa de participação (%)
Implementar metodologia SBAR para padronização de comunicação.	Adesão ao protocolo em transições de cuidado (%)
Mapear e revisar fluxos de pacientes de alto risco (ASA III/IV) com reserva prévia de leitos críticos	Redução de encaminhamentos não programados à UTI (%)

● Ações de processo ● Ações de capacitação

Recomendações – Longo Prazo (>120 dias)

Consolidação de Maturidade

Iniciativas estruturantes para evolução da cultura de segurança e consolidação de mecanismos preventivos:

Ação	Indicador
Implantar painel dos indicadores para tempo-resposta a eventos críticos, taxa de encaminhamentos não programados à UTI e adesão a protocolos	Relatórios trimestrais e variações percentuais
Consolidar reuniões mensais de aprendizado institucional, integrando Anestesia, Enfermagem e Cirurgia	Número de reuniões realizadas e ações implementadas
Integração digital entre notificações, auditorias e indicadores assistenciais.	Tempo médio de detecção e fechamento de ações corretivas
Implementar sistema automatizado de bloqueio e alertas para falhas processuais previsíveis.	% de redução de eventos recorrentes de falhas na adesão barreiras preventivas

Evolução gradual de um modelo reativo para um sistema preventivo e inteligente, com integração de dados e análise preditiva.

Conclusões e Próximas Etapas

Prioridades Estratégicas

Prioridade Estratégica	KPI sugerido	Impacto
Planejamento antecipado de risco e leito crítico	% ASA III/IV com leito crítico reservado	
Automação de protocolos críticos	% de bloqueios/alertas efetivos	
Monitoramento de adesão processual e comunicação	Adesão ao Time Out e SBAR (%)	

Próximo ciclo: Análise mensal de eventos críticos e revisão de barreiras preventivas. Foco em evolução de sistema reativo para modelo preventivo e inteligente.

Evolução

+275%

Aumento de notificações Jul-Set/2025

Segurança

60%

Eventos sem dano ou dano leve

Maturidade

54%

Notificações via sistema digital (Axreg)